

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ · ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Организация вариативного питания в домах социального обслуживания

Рассказ о том, как вернуть человеку право самому решить, что окажется у него на тарелке, — с сомнениями, ошибками и честностью о том, чего мы пока не знаем.

Чистяков Е. В., директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“»

От автора

Больше десяти лет я руковожу стационарным учреждением для людей с психическими нарушениями — большим петербургским домом, где живёт больше тысячи человек. Эти страницы — не отчёт и не инструкция. Это рассказ о том, как мы попробовали вернуть нашим жителям одну очень простую вещь, которой их лишили давно и почти незаметно, — право самому решить, что окажется у тебя на тарелке. Рассказ честный: с сомнениями, ошибками и теми местами, где у нас пока нет ни цифр, ни готовых ответов.

Я пишу для коллег-директоров, которые каждый день принимают решения за сотни людей и знают цену слову «нельзя». И я знаю, что эти строки прочитают в Министерстве, поэтому не стану ни приукрашивать, ни жаловаться. Скажу как есть.

Часть первая. Обед, которого мы не замечаем

Зайдите в столовую большого интерната в обеденный час — и первое, что вы услышите, будет тишина. Не та тишина, что бывает от покоя, а рабочая, деловитая: звон половников, шорох подносов, короткие команды помощников. Сто двадцать человек едят одно и то же, из одинаковых тарелок, в одном и том же порядке, в котором ели вчера и будут есть завтра. Никто не спросил их, чего им хочется. Никто и не думал, что об этом стоит спрашивать.

Присмотритесь к одному столу. Женщина лет шестидесяти сидит перед полной тарелкой каши и не притрагивается к ней. Она не больна и не капризничает — она просто не любит эту кашу и не ест её уже третий день. Об этом никто не знает, потому что журнала, куда записывают отказы, в отделении нет, а врач приходит на обход по четвергам. Через две недели она потеряет в весе, и тогда мы забеспокоимся и станем искать болезнь. Болезни не будет. Будет каша, которую она не любит, и наша привычка не спрашивать.

За соседним столом мужчина торопливо доедает и просит добавки. Помощник отказывает — мягко, почти ласково: «вам нельзя, вы и так поправились». Никакой врач такого ограничения не назначал. Просто когда-то кто-то решил, что так будет правильнее, и это «правильнее» переходит из смены в смену, обрастая уверенностью, которой у него нет.

Третий житель принимает сильное лекарство, а родные принесли ему термос крепкого кофе — из любви, чтобы порадовать. Они не знают, что для его лекарства кофе не безобиден: он меняет то, как препарат ведёт себя в крови. И мы не знаем, что они его принесли, потому что и об этом спросить забыли.

Я мог бы продолжать. У каждого стола своя маленькая история, и в каждой на первый взгляд есть виноватый: медлительный помощник, привередливая жительница, неосторожная семья. Но чем дольше я работаю, тем яснее вижу: виноватых здесь нет. Есть наша система, устроенная так, что человек в ней — не тот, кого спрашивают, а тот, кого обслуживают. И еда — самое честное её зеркало. Потому что еда повторяется чаще всего остального. Лекарство дают по расписанию, врач приходит по графику, родные навещают по выходным. А есть человек хочет каждый день, по нескольку раз, всю жизнь. Если и в этом, самом частом, за него всё решают другие, то никакие красивые слова о правах и достоинстве до его тарелки не доберутся.

Почему это оказалось важнее, чем я думал

Долгое время я, как и многие, считал вопрос питания хозяйственным. Нормы, калории, санитарные требования, поставщики — важное, хлопотное, но не то, ради чего идёшь в эту профессию. Мысль, что тарелка каши способна быть вопросом человеческого достоинства, пришла ко мне не из книг, а из наблюдения.

У нас жила женщина, которая почти не говорила. Годами она ела то, что ставили, не выражая ни радости, ни недовольства, — так, как ест человек, давно переставший ждать, что его о чём-то спросят. Однажды на раздаче случайно оказалось два вторых блюда, и помощница, скорее от растерянности, чем по методике, показала ей обе тарелки: «какое?». Женщина посмотрела на них долго, внимательно — и показала пальцем. В этом жесте не было ничего особенного, и всё же я запомнил его надолго. Человек, за которого годами всё решали, вдруг решил сам. Маленькое, почти незаметное событие — а по сути возвращённое право.

С этого началось моё понимание, что вариативное питание — не про меню и не про сервис. Оно про то, доходит ли наша забота до человека или останавливается на пороге его самостоятельности. И когда я это понял, стало ясно и другое: одной доброй воли тут мало. Между желанием «дать людям выбор» и безопасным, законным, устойчивым порядком лежит немалая работа, и обойти её нельзя. Об этой работе — и обо всём, что мы на ней узнали, в том числе неприятного, — дальше и пойдёт речь.

Два соблазна, которые лучше отбросить сразу

Прежде чем рассказывать, как мы это делали, назову две ловушки, в которые легко попасть, — я сам едва их миновал.

Первая: решить, что выбор блюда — баловство, украшение, до которого дойдут руки, когда будет закрыто всё остальное. Это ошибка. Однообразная еда, которую не хотят, — не мелочь: это несъеденные калории, растущее раздражение в зале и самый частый повод для жалоб. Выбор здесь работает не на удовольствие, а на то, чтобы еда была съедена.

Вторая ловушка обратная: поверить, будто для настоящего выбора нужен ресторан — вторая кухня, новые ставки, отдельная смета. Это тоже неправда, и неправда опасная, потому что она даёт удобный повод не начинать: денег нет — значит, и говорить не о чем. На нашем опыте я убедился, что первый и главный шаг не стоит почти ничего. Он стоит решимости спросить человека и готовности записать его ответ.

Обе ловушки сходятся в одном: они мешают увидеть вариативное питание таким, какое оно есть, — не подарком и не роскошью, а обычной, выполнимой работой, у которой есть свои правила безопасности. К этим правилам мы ещё вернёмся, и не раз. А пока — о том, с чего у нас всё началось.

Часть вторая. Как мы решились

Признаюсь честно: начинать было страшно. Директор большого дома отвечает за всё и понимает риски раньше, чем возможности. Дать людям выбор — звучит красиво, но за этим сразу встают тревожные вопросы. А вдруг человек с нарушением глотания подавится незнакомой едой? А вдруг тот, кому назначена диета, выберет запрещённое и навредит себе? А что скажет проверка, увидев в тарелках не то, что в утверждённой раскладке? Эти страхи не выдуманные, и отмахнуться от них нельзя. Но именно они, если к ним прислушаться, подсказывают, как действовать правильно.

Первое, что мы поняли: начинать нужно не с меню, а с границы. Есть решения, которые не принимает кухня, — и это не умаление её роли, а защита. Какая пища по густоте безопасна человеку, который рискует поперхнуться; можно ли ему то или иное блюдо при его лекарствах; нужна ли ему лечебная диета — всё это решает врач, и только врач. Кухня исполняет назначение, но не ставит диагноз. Пока эта граница не проведена и не записана, никакого выбора вводить нельзя: без неё вариативность из заботы превращается в опасность. Мы начали с того, что посадили за один стол заведующего производством и врача и разобрали, где кончается «вкусно» и начинается «назначено». Это оказалось важнее любого меню.

КТО ЧТО РЕШАЕТ ЗА СТОЛОМ

Решение	За кем последнее слово
Ограничения рациона, лечебная диета	Врач
Густота пищи при риске поперхнуться	Врач
Учёт лекарств и еды	Врач; кухня исполняет по таблице
Какое из двух равноценных блюд сегодня	Житель
Технология раздачи, подбор пар блюд	Заведующий производством
Финансирование, ставки, официальный статус	Учредитель

Граница проведена один раз и записана. Внутри неё выбор жителя безопасен; без неё — опасен.

Второе: мы не стали менять всё сразу. Сблазн объявить реформу на весь дом велик, и он губителен — в доме на тысячу человек сбой такого масштаба бьёт по всем. Мы взяли одно отделение, один приём пищи и предложили жителям простую вещь: накануне выбрать из меню, что они хотят на завтра. Не шведский

стол, не ресторан — два понятных, равноценных по составу варианта. Гречка или рис. Курица или рыба. Одно и то же сырьё, одна и та же норма, но человек сам сказал, чего он хочет, и на завтра получил именно это. Выбор мы записывали — сначала в обычную тетрадь. Эта тетрадь и стала первым настоящим документом проекта: она превращала добрую волю в проверяемый факт.

Отдельного слова заслуживают наши сотрудники. Их страхи были искренними и заслуженными: любая новизна ложится нагрузкой на смену, а смена и без того работает на пределе. «Будут капризничать», «перепутаем», «не успеем» — я слышал это не раз. И здесь я не буду делать вид, будто нашёл волшебное слово. Помогло другое: мы дали людям увидеть результат своими глазами. Когда помощник, месяц отработавший на выборе, сам говорит коллегам, что стало не тяжелее, а понятнее, — это убеждает сильнее любого приказа. У соседей, в новосибирских домах, где вариативное питание запустили раньше нас, отмечали то же самое: опасения персонала не подтвердились, а жители освоили новый порядок легко. Чужой опыт здесь дорогого стоит: он снимает у команды ощущение, что мы первопроходцы на минном поле.

Часть третья. Когда выбор стал правилом дома

Настоящий перелом случился не в тот день, когда жители впервые что-то выбрали, а позже — когда выбор перестал быть нашей доброй причудой и стал порядком, закреплённым на бумаге. Пока практика держится на энтузиазме одного директора и нескольких сочувствующих сотрудников, она хрупка: сменится руководитель, устанет смена — и всё вернётся к одной тарелке на всех. Чтобы этого не случилось, нужно перевести живое дело в устойчивую форму.

Мы закрепили заказное питание в правилах внутреннего распорядка дома — отдельным приказом. С этого момента возможность выбрать рацион перестала быть экспериментом, о котором можно рассказать в новости, и стала нормой нашего учреждения, на которую можно сослаться. Для маломобильных жителей мы прямо записали, что приём пищи и помощь в кормлении осуществляются в комнатах. Это важная деталь: право выбора нельзя оставлять только тем, кто дошёл до столовой. Тот, кого кормят в постели, имеет на выбор ровно столько же прав, сколько и все.

Здесь я хочу быть предельно честным, потому что честность в этом деле дороже красивой цифры. Наш переход дался не даром. Чтобы наладить заказное питание, дом закупил дополнительное оборудование и добавил сотрудников. Слова «без новой сметы», которые вы иногда услышите на семинарах, верны только для первого, пробного шага на одном отделении. Полный перевод большого дома на вариативное питание требует ресурсов, и делать вид, что это не так, я не стану. Мы назвали и другие свои трудности вслух: держать баланс рациона, когда люди сами выбирают; помнить о здоровье тех, кто склонен выбирать вкусное, а не полезное; понимать, что полный переход всего дома — задача не на один год. Я рассказываю об этом не чтобы отпугнуть, а чтобы вы шли с открытыми глазами. Проект, который прячет свою цену, разваливается на первой же проверке. Проект, который называет её сам, вызывает доверие.

И всё же, оглядываясь назад, я вижу главное: ни один из наших шагов не начинался со слов «сначала дайте денег». Он начинался с решения спросить человека. Так же было и у коллег — в новосибирских домах, в Усть-Илимске, в Иркутской области, где выбор из нескольких первых, вторых и гарниров вводят уже в масштабе региона. Мы разные, у нас разные бюджеты и разные учредители, но точка старта у всех оказалась одна и та же — не деньги, а готовность вернуть жителю голос.

Часть четвёртая. Что мы советуем тем, кто решится

Если из всего нашего опыта выбрать несколько советов, которые я дал бы коллеге накануне старта, они уместятся на одной странице. Их немного, но за каждым — набитые шишки.

Начните с врача, а не с меню. Первым делом проведите и запишите границу: какие ограничения, текстуры и диеты остаются в руках врача. Пока эта граница не ясна смене, выбор вводить рано. Это не тормоз, это фундамент: он один защищает и жителя, и вас.

Начните с малого. Одно отделение, один приём пищи, два равноценных варианта, заказ накануне. Лучше взять отделение потруднее — с теми, кому нужна помощь, с теми, кто не говорит. Если получится там, получится везде; если начать с удобных и потом столкнуться со сложными, дело развалится и похоронит идею.

Записывайте с первого дня. Обычная тетрадь, куда заносят выбор, отказы и замены, важнее любой красивой презентации. Она превращает вашу добрую волю в факт, который видит и учредитель, и проверяющий. Без неё та же самая практика выглядит как отступление от раскладки; с ней — как продуманное решение.

Считайте честно. Прежде чем менять, замерьте: сколько еды возвращается нетронутой, как долго идёт раздача, сколько длится ночной перерыв между ужином и завтраком. Через три месяца сравните. Без замера «до» вам нечего будет предъявить — ни себе, ни учредителю, ни тем, кто придёт следом.

И, может быть, самое главное. Не обещайте того, чего не знаете. Я не могу доказать вам, что выбор блюда продлевает жизнь или снижает число болезней, — таких исследований в нашей области пока попросту нет, и я не стану выдавать надежду за знание. Но я твёрдо знаю другое: организовать выбор безопасно и за понятную цену можно, а дошёл ли он до тарелки — можно проследить и измерить. Поэтому последнее слово этих рекомендаций — не «внедряйте», а «измеряйте». Семь дней честного замера отделяют убеждение от знания.

ПИЛОТ НА 90 ДНЕЙ: ТРИ ШАГА БЕЗ СПЕШКИ

1

Месяц замера

считаем отходы, время
раздачи, ночной перерыв
— цифры «до»

2

Месяц подготовки

граница врача, положение
и журналы, обучение
смены

3

Месяц выбора

два варианта на одном
приёме, ежедневная
запись, сравнение с «до»

Одно отделение, один приём пищи. Лучшее отделение потруднее: получится там — получится везде.

Часть пятая. Шесть вопросов, которые мы вынесем на обсуждение

На секции мы с коллегой не будем раздавать готовые ответы — эти вопросы для того и трудные, чтобы обсуждать их вместе с залом. Но прийти на разговор без собственной позиции было бы нечестно. Вот шесть вопросов и короткие мысли, с которыми иду я.

1. Кто выбирает форму питания — проживающий или руководитель дома? И тот и другой, но каждый — своё. Руководитель задаёт рамку: какая модель по силам дому, что безопасно, где проходит врачебная граница. Житель выбирает внутри этой рамки. Проще всего сказать так: дом решает, что он в состоянии приготовить, а человек — что из этого он хочет съесть.

2. Как формировать меню при жёстких нормативных и финансовых ограничениях? Через пары равноценных блюд внутри той же нормы и того же сырья: гречка или рис, курица или рыба. Норматив задаёт верхнюю границу расходов, а требование к качеству — нижнюю границу товара, и её мы прописываем в задании поставщику до торгов. Выбор не требует выхода за норму — он требует порядка внутри неё.

3. Должно ли питание в социальных домах быть «лечебным»? Лечебным оно становится там и только там, где его поимённо назначил врач — с целью и сроком пересмотра. Обязательной «больничной» диеты для всех наш профиль не предполагает. Путать заботу о здоровье с тотальным ограничением — распространённая и дорогая ошибка.

4. Как совместить «лечебное питание» и «вариативное меню», не ограничивая право на выбор? Диета сужает множество блюд, но редко сводит его к одному. Даже внутри назначенного стола почти всегда можно предложить пару — две подходящие крупы, два источника белка. Выбор внутри диеты — не противоречие врачу, а уважение к человеку, который эту диету соблюдает.

5. Как соблюсти баланс между выбором недееспособного и его медицинскими рекомендациями? Повседневное «хочу это, а не то» — обычно не сделка и не медицинское решение, и мнение человека мы обязаны выяснить и учесть. Там, где его выбор всерьёз расходится с назначением, работает не тихий запрет, а решение комиссии с записанной причиной и понятной альтернативой. Разница между запретом и отклонением по показаниям — это разница между произволом и медициной.

6. Как совместить качество продуктов и нормирование цен при планировании бюджета? Считать стоимость не сырья на складе, а блюда в

тарелке жителя. Экономить на потерях — на том, что выбрасывается несъеденным, — а не на белке. И начинать не с лозунга о качестве, а с простого замера: сколько на самом деле стоит день питания одного человека в вашем доме. Часто эту цифру никто не может назвать сразу — и это первая находка честного аудита.

Вместо заключения

Я начал этот рассказ с тихой столовой, где сто двадцать человек ели одно и то же, и с женщины, которая впервые за годы показала пальцем на тарелку, которую выбрала сама. Этим и закончу. Вариативное питание — не про кухню и не про деньги. Оно про то, остаётся ли человек, доверенный нашей заботе, человеком — тем, кого спрашивают, а не только тем, кого обслуживают.

Мы в самом начале пути и не скрываем его трудностей. Но я видел лица наших жителей в тот день, когда их впервые о чём-то спросили, и ради этих лиц стоит пройти всю неблагодарную работу с журналами, приказами и замерами. Право выбора становится настоящим не тогда, когда его записали в устав, а тогда, когда его можно проследить до конкретной тарелки конкретного человека. Довести его туда — в наших силах. Приглашаю коллег пройти этот путь вместе.

Источники и литература

1. Приказ директора СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“» от 10.03.2026 № 124 «Об утверждении правил внутреннего распорядка жителей» (заказное питание — вариативное меню, помощь в кормлении маломобильным гражданам в жилых комнатах).
2. Сообщение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 22.07.2025 о первых результатах вариативного меню в ДСО «Серафимовский».
3. Публичные сообщения об опыте вариативного питания: ГАУССО НСО «Болотнинский ПНИ» (16.08.2024); ГАУССО НСО «Успенский ПНИ» (13.08.2024); ОГБУСО «Усть-Илимский дом социального обслуживания» (27.09.2024); Иркутская область (14.02.2025).
4. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (ст. 9, 16).
5. Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» (ст. 5, 43).
6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (до 31.08.2026); СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (с 01.09.2026, п. 56 подп. 11 — питание в стационарных организациях социального обслуживания не менее трёх раз в день, в том числе диетическое по медицинским показаниям).
7. Исследование проекта «Если быть точным» об устройстве психоневрологических интернатов в России (данные за 2024 год, публикация 2026).